

GEBELİKTE HİPERTANSİYF HASTALIKLAR

BÖLÜM I — TUS TARZI VAKA SORULARI

1. 32 yaşında, 28 haftalık gebede daha önce hipertansiyon öyküsü yoktur. Dört saat arayla yapılan iki ölçümde kan basıncı 148/94 mmHg ve 150/96 mmHg saptanıyor. Proteinüri yoktur; trombosit sayısı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldir.

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Kronik hipertansiyon
- B) Preeklampsi
- C) Gestasyonel hipertansiyon
- D) Süperempoze preeklampsi
- E) Eklampsi

2. 10 haftalık gebenin ilk antenatal vizitinde, tekrarlanan ölçümlerde kan basıncı 150/95 mmHg bulunuyor. Daha önce hipertansiyon tanısı almamıştır.

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Preeklampsi
- C) Kronik hipertansiyon
- D) Eklampsi
- E) HELLP sendromu

3. 31 haftalık gebede kan basıncı 165/110 mmHg ölçülüyor. İdrarda proteinüri negatiftir. Trombosit sayısı 92.000/ μ L, serum kreatinin 1,3 mg/dL bulunuyor.

Bu hasta için en doğru tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Preeklampsi
- D) Eklampsi
- E) HELLP sendromu

4. **Aşağıdakilerden hangisi preeklampsinin ciddi (şiddetli) özelliklerinden biri değildir?**

- A) Kan basıncının 162/112 mmHg olması
- B) Trombosit sayısının 90.000/ μ L olması
- C) Pulmoner ödem
- D) Persistan görme bozukluğu
- E) 24 saatlik idrarda 350 mg proteinüri

5. 34 haftalık gebede kan basıncı 172/114 mmHg ölçülüyor; 20 dakika sonra tekrarlanan ölçümde 170/112 mmHg bulunuyor.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) 24 saatlik idrar proteini sonucunu beklemek
- B) Metildopa başlamak
- C) Akut antihipertansif tedaviyi başlamak
- D) Yalnızca fetal NST yapmak
- E) 24 saat sonra kan basıncını tekrar ölçmek

6. **Gebelikte akut ciddi hipertansiyonun tedavisinde aşağıdakilerden hangisi standart ilk basamak seçeneklerden biri değildir?**

- A) IV labetalol
- B) IV hidralazin
- C) Oral hızlı salımlı (immediate-release) nifedipin
- D) Oral metildopa
- E) IV labetalole yanıt alınamazsa IV hidralazine geçilmesi

7. 35 haftalık preeklamps tanılı gebede jeneralize tonik-klonik nöbet geliyor.

Bu hastada ilk tercih edilmesi gereken antikonvülzan ilaç hangisidir?

- A) Diazepam
- B) Fenitoin
- C) Magnezyum sülfat
- D) Valproat
- E) Midazolam

8. Eklamps nedeniyle magnezyum sülfat infüzyonu alan hastada patellar refleksler kayboluyor ve solunum sayısı 8/dk'ya düşüyor.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) Magnezyum sülfat dozunu artırmak
- B) Kalsiyum glukonat vermek
- C) Diazepam vermek
- D) Labetalol vermek
- E) Furosemid vermek

9. 33 haftalık gebe epigastrik ağrı ile başvuruyor.

- Kan basıncı: 165/105 mmHg
- AST ve ALT: yüksek
- Trombosit: 68.000/ μ L
- LDH: belirgin yüksek

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
- B) HELLP sendromu
- C) Trombotik trombositopenik purpura (TTP)
- D) Hemolitik üremik sendrom (HÜS)
- E) Gestasyonel hipertansiyon

10. HELLP sendromunda hemolizi destekleyen laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) LDH düzeyinin düşük olması
- B) İndirekt bilirubin artışı
- C) Haptogloblin artışı
- D) Retikülositopeni
- E) Direkt bilirubin artışı

11. Kronik hipertansiyonu olan ve daha önce proteinürisi saptanmamış 30 haftalık gebede yeni başlayan 2+ proteinüri ve trombositopeni gelişiyor.

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Süperempoze preeklampsi
- D) Eklampsi
- E) HELLP sendromu

12. Preeklampside uteroplental perfüzyon bozukluğunun en karakteristik fetal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makrozomi
- B) Fetal büyüme kısıtlılığı
- C) Polihidramnios
- D) Postmatürite
- E) Fetal hipertiroidi

13. Önceki gebeliğinde 30. haftada ağır preeklampsi nedeniyle doğum yapmış olan kadın şu an 10 haftalık gebedir.

Bu hasta için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi uygundur?

- A) Gebelik boyunca magnezyum sülfat verilmesi
- B) 12. haftadan itibaren düşük doz aspirin başlanması
- C) 20. haftadan itibaren ACE inhibitörü başlanması
- D) Rutin diüretik kullanımı
- E) Tuz kısıtlaması

14. Düşük doz aspirin profilaksisi aşağıdaki durumların hangisinde rutin olarak önerilmez?

- A) Önceki preeklampsi öyküsü
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Çoğul gebelik
- D) Tip 1 diyabet
- E) Preeklampsi risk faktörü olmayan gebede yalnızca fetal büyüme kısıtlılığını önleme amacı

15. Eklampsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antepartum dönemde gelişebilir.
- B) İntrapartum dönemde gelişebilir.
- C) Postpartum dönemde gelişebilir.
- D) Yalnızca doğumdan önce gelişir.
- E) Tedavide temel ilaç magnezyum sülfattır.

16. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi gebelikte kontrendikedir?

- A) Labetalol
- B) Nifedipin
- C) Metildopa
- D) Enalapril
- E) Hidralazin

17. 37 haftalık gebede preeklampsi tanısı mevcuttur. Maternal ve fetal durum stabildir.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) 40. haftaya kadar beklemek
- B) Gebeliği süresiz sürdürmek
- C) Doğumu planlamak
- D) Magnezyum sülfat altında 39. haftaya kadar beklemek
- E) ACE inhibitörü başlamak

18. 29 haftalık preeklampsi tanılı gebede kan basıncı tedaviye rağmen kontrol altına alınamıyor ve pulmoner ödem geliyor.

Bu hastada en doğru yaklaşım hangisidir?

- A) Gebeliği rutin olarak 37. haftaya kadar sürdürmek
- B) Yalnızca aspirin başlamak
- C) Maternal stabilizasyon sonrası doğumu gerçekleştirmek
- D) ACE inhibitörü başlamak
- E) Yalnızca fetal büyümeyi takip etmek

19. Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi için yüksek risk faktörlerinden biridir?

- A) Tek başına nulliparite
- B) 35 yaşında olmak
- C) Kronik hipertansiyon
- D) İki gebelik arasındaki sürenin 3 yıl olması
- E) Hafif demir eksikliği

20. 34 haftalık gebe şiddetli frontal baş ağrısı ve görme bulanıklığı ile başvuruyor.

- Kan basıncı: 170/112 mmHg
- Trombosit: 78.000/ μ L
- AST: 180 U/L
- Kreatinin: 1,4 mg/dL
- Proteinüri: 1+

Bu hasta için en doğru yaklaşım hangisidir?

- A)** Gestasyonel hipertansiyon kabul edilip izlenmesi
- B)** Proteinüri miktarı düşük olduğu için preeklampsinin dışlanması
- C)** Ciddi özellikli preeklampsisi düşünülerek maternal stabilizasyon, $MgSO_4$ ve uygun antihipertansif tedavinin planlanması
- D)** Yalnızca aspirin başlanması
- E)** 37. haftaya kadar beklenmesi

BÖLÜM II — ZOR VAKALAR

1. 32 yaşında, G2P1 kadın 31. gebelik haftasında baş ağrısı ve görmede bulanıklık yakınmasıyla başvuruyor.

- Kan basıncı: 148/94 mmHg
- 24 saatlik idrarda protein: 280 mg/gün
- Trombosit: 82.000/ μ L
- AST: normal
- Kreatinin: 0,9 mg/dL

Bu hasta için en doğru tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Proteinürisiz preeklampsi
- D) Ciddi özellikli preeklampsi
- E) Kronik hipertansiyon üzerine süperempoze preeklampsi

2. 35 haftalık gebede kan basıncı 168/112 mmHg ölçülüyor; 15 dakika sonra tekrarlanan ölçümde 166/110 mmHg bulunuyor. Hasta asemptomatiktir. İdrar stick testinde proteinüri (+) saptanıyor.

Bu hastada ilk yapılması gereken yaklaşım hangisidir?

- A) 24 saatlik idrar proteinini tamamlamak
- B) Betametazon uygulayıp 24 saat beklemek
- C) Antihipertansif tedaviyi acilen başlamak
- D) Magnezyum sülfat başlayıp doğumu gerçekleştirmek
- E) Doppler USG sonucunu beklemek

3. 39 haftalık preeklampsi tanılı kadın doğum sırasında jeneralize tonik-klonik nöbet geçiriyor ve magnezyum sülfat ($MgSO_4$) başlanıyor. Bir süre sonra aşağıdaki bulgular geliyor:

- Patellar refleksler kayboluyor
- Solunum sayısı 9/dk
- İdrar çıkışı belirgin azalmış

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) Diazepam
- B) Fenitoin
- C) Kalsiyum glukonat
- D) Labetalol
- E) Furosemid

4. 34 haftalık gebe bulantı, sağ üst kadranda ağrısı ve halsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar bulguları şöyledir:

- Hemoglobin: 8,9 g/dL
- LDH: 920 U/L
- AST: 180 U/L
- ALT: 150 U/L
- Trombosit: 72.000/ μ L
- Bilirubin: yüksek
- Kreatinin: 1,3 mg/dL
- Glukoz: normal

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
- B) HELLP sendromu
- C) Trombotik trombositopenik purpura (TTP)
- D) Gebeliğin intrahepatik kolestazi
- E) Hemolitik üremik sendrom (HÜS)

5. Daha önce kronik hipertansiyon tanısı almış 10 haftalık gebe antihipertansif ilaç kullanmıyor. Tekrarlayan ölçümlerde kan basıncı 146/92 mmHg bulunuyor. Proteinüri yoktur, laboratuvar tetkikleri normaldir.

Güncel kanıtlar doğrultusunda bu hastanın yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

- A) Tedaviye ancak kan basıncı 160/110 mmHg olduğunda başlanmalıdır.
- B) Antihipertansif tedavi gebelik boyunca kontrendikedir.
- C) Antihipertansif tedavi düşünülmeli ve hedef kan basıncı <140/90 mmHg olacak şekilde yönetilmelidir.
- D) Magnezyum sülfat başlanmalıdır.
- E) Aspirin başlanması antihipertansif tedavinin yerine geçer.

6. Kronik hipertansiyonu olan 28 haftalık gebenin bulguları şöyledir:

- Başlangıç proteinürisi: 150 mg/24 saat
- Şimdiki proteinüri: 1,2 g/24 saat
- Kan basıncı: 152/96 mmHg
- Trombosit: 95.000/ μ L
- AST: 110 U/L

Bu hasta için en uygun tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Süperempoze preeklampsi
- D) HELLP sendromu
- E) Kronik böbrek hastalığına bağlı proteinüri

7. Preeklampsi açısından yüksek riskli 13 haftalık gebeye koruyucu tedavi olarak düşük doz aspirin planlanıyor.

Aspirin kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi güncel önerilere en uygundur?

- A) 20. haftadan sonra başlanmalıdır.
- B) 12-28. haftalar arasında başlanabilir; ideal olarak 16. haftadan önce başlanması tercih edilir.
- C) Yalnızca proteinüri başladıktan sonra verilmelidir.
- D) Yalnızca hipertansiyon geliştiğinde başlanmalıdır.
- E) Doğuma kadar değil, 28. haftada kesilmelidir.

8. 36+4 haftalık preeklampsi tanılı gebenin bulguları şöyledir:

- Kan basıncı: 148/94 mmHg
- Trombosit: 145.000/ μ L
- AST: normal
- Kreatinin: normal
- Fetal büyüme: normal
- CTG: normal
- Semptom yok

NICE önerilerine göre bu hastada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en doğrudur?

- A) 34. haftada doğum yapılmalıydı.
- B) 37. haftaya kadar her koşulda beklenmelidir.
- C) 37. haftadan itibaren doğumun başlatılması önerilir.
- D) Yalnızca proteinüri 5 g/gün üzerine çıkarsa doğum yapılır.
- E) Sezaryen ile doğum zorunludur.

9. 30 haftalık gebenin ultrasonografisinde fetal hidrops, plasentomegali ve polihidramnios saptanıyor. Annenin muayene ve tetkiklerinde ise aşağıdaki bulgular vardır:

- Yaygın ödem
- Kan basıncı: 150/95 mmHg
- Proteinüri: (+)
- Hafif anemi

Bu tabloda özellikle hangi tanı düşünülmelidir?

- A) HELLP sendromu
- B) Mirror (ayna) sendromu
- C) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
- D) Kronik hipertansiyon
- E) Trombotik trombositopenik purpura (TTP)

10. 32 haftalık gebenin bulguları şöyledir:

- Kan basıncı: 135/85 mmHg
- Trombosit: 28.000/ μ L
- Hemoglobin: 7,6 g/dL
- LDH: çok yüksek
- Periferik yaymada şistosit: (+)
- AST: 65 U/L
- ALT: 55 U/L
- Kreatinin: 2,4 mg/dL
- Belirgin proteinüri yok
- Nörolojik semptomlar mevcut

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A)** HELLP sendromu
- B)** Preeklampsia
- C)** Trombotik trombositopenik purpura (TTP)
- D)** Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
- E)** Gestasyonel trombositopeni

CEVAP ANAHTARI VE AÇIKLAMALAR

Bölüm I — TUS Tarzı Vaka Soruları

1 C	2 C	3 C	4 E	5 C	6 D	7 C	8 B	9 B	10 B
11 C	12 B	13 B	14 E	15 D	16 D	17 C	18 C	19 C	20 C

Soru 1 — Cevap: C) Gestasyonel hipertansiyon

Gebeliğin 20. haftasından sonra ilk kez ortaya çıkan ($\geq 140/90$ mmHg, en az 4 saat arayla iki ölçüm) hipertansiyona proteinüri veya maternal organ disfonksiyonu eşlik etmiyorsa tanı **gestasyonel hipertansiyondur**. Bu hastaların bir kısmı izlemde preeklampsiye ilerleyebileceği için takip sürdürülür.

Soru 2 — Cevap: C) Kronik hipertansiyon

Gebelikten önce bilinen veya gebeliğin **20. haftasından önce** saptanan hipertansiyon **kronik hipertansiyon** kabul edilir. Daha önce tanı konmamış olması bu tanıyı değiştirmez. Doğum sonrası 12 haftadan uzun süren hipertansiyon da kronik hipertansiyonu düşündürür.

Soru 3 — Cevap: C) Preeklampsi

Preeklampsi tanısı için **proteinüri şart değildir**. 20. haftadan sonra gelişen hipertansiyona trombositopeni ($<100.000/\mu\text{L}$), böbrek yetmezliği (kreatinin $>1,1$ mg/dL veya bazalin iki katı), karaciğer tutulumu, pulmoner ödem ya da serebral/görsel semptomlardan biri eşlik ederse preeklampsi tanısı konur. Bu hastada hem kan basıncı düzeyi hem trombositopeni hem de kreatinin yüksekliği **ciddi özellik** kriteridir; tablo ciddi özellikli preeklampsidir.

Soru 4 — Cevap: E) 24 saatlik idrarda 350 mg proteinüri

Proteinürinin miktarı (masif proteinüri dahil) güncel tanımlarda **ciddi özellik kriteri değildir**. Ciddi özellikler: sistolik ≥ 160 veya diyastolik ≥ 110 mmHg, trombosit $<100.000/\mu\text{L}$, transaminazların normalin üst sınırının 2 katından fazla yükselmesi veya şiddetli sağ üst kadr/epigastrik ağrı, kreatinin $>1,1$ mg/dL veya bazalin iki katı, pulmoner ödem, yeni başlayan ve tedaviye yanıtız baş ağrısı, görme bozukluğu.

Soru 5 — Cevap: C) Akut antihipertansif tedaviyi başlamak

Sistolik ≥ 160 mmHg veya diyastolik ≥ 110 mmHg olan ve 15 dakika sonra tekrarlanan ölçümde devam eden kan basıncı **akut ciddi hipertansiyondur**; maternal inme riskini azaltmak için tedavi gecikmeden (ideal olarak 30–60 dakika içinde) başlanmalıdır. İlk basamak seçenekler: IV labetalol, IV hidralazin veya oral hızlı salınlı (immediate-release) nifedipin.

Soru 6 — Cevap: D) Oral metildopa

Metildopa etkisi yavaş başlayan bir ilaçtır; gebelikte kronik hipertansiyonun idame tedavisinde kullanılabilir ancak akut hipertansif acilde tercih edilmez. Akut tedavide IV labetalol, IV hidralazin ve oral hızlı salınlı nifedipin kullanılır; bir ajana yanıt alınamazsa diğerine geçilir.

Soru 7 — Cevap: C) Magnezyum sülfat

Preeklampsi zemininde başka bir nedenle açıklanamayan nöbet = **eklampsi**. Hem tedavide hem de nöbet tekrarının önlenmesinde ilk seçenek **magnezyum sülfattır** (MgSO_4); fenitoin ve diazepam üstünlüğü randomize çalışmalarla gösterilmiştir.

Soru 8 — Cevap: B) Kalsiyum glukonat vermek

Derin tendon reflekslerinin kaybı ve solunum depresyonu **magnezyum toksisitesini** gösterir. İnfüzyon hemen durdurulur, solunum desteklenir ve antidot olarak **kalsiyum glukonat** (%10'luk solüsyondan 10 mL, yaklaşık 1 g, IV yavaş) verilir; serum magnezyum düzeyi kontrol edilir. Sıra hatırlatması: önce refleks kaybı, sonra solunum depresyonu, en son kardiyak arrest.

Soru 9 — Cevap: B) HELLP sendromu

HELLP = **H**emolysis (hemoliz) + **E**levated **L**iver enzymes (karaciğer enzimlerinde artış) + **L**ow **P**latelets (düşük trombosit). Epigastrik/sağ üst kadranda ağrısı tipik yakınmadır. Tennessee kriterleri: LDH ≥ 600 U/L, AST ≥ 70 U/L, trombosit $\leq 100.000/\mu\text{L}$.

Soru 10 — Cevap: B) İndirekt bilirubin artışı

Hemolizde **LDH ↑**, **indirekt bilirubin ↑**, **haptoglobin ↓** beklenir; periferik yaymada şistositler görülür. Retikülosit sayısı artar. Direkt bilirubin artışı kolestatik/hepatoselüler süreçleri düşündürür, hemolizin göstergesi değildir.

Soru 11 — Cevap: C) Süperempoze preeklampsi

Kronik hipertansiyon zemininde 20. haftadan sonra **yeni başlayan proteinüri**, önceden var olan proteinüride ani artış, kan basıncı kontrolünün bozulması veya yeni organ disfonksiyonu (trombositopeni, transaminaz artışı vb.) gelişmesi **süperempoze preeklampsi** tanısını düşündürür.

Soru 12 — Cevap: B) Fetal büyüme kısıtlılığı

Preeklampside spiral arterlerin yetersiz remodelingi sonucu gelişen **uteroplasental yetmezlik**, fetal büyüme kısıtlılığı (FGR) ve oligohidramnios yol açar. Makrozomi ve polihidramnios bu fizyopatolojiyle uyumlu değildir.

Soru 13 — Cevap: B) 12. haftadan itibaren düşük doz aspirin başlanması

Önceki preeklampsi (özellikle erken/ağır) **yüksek risk faktörüdür**. ACOG/SMFM, yüksek riskli gebelerde günlük **81 mg** düşük doz aspirinin 12-28. haftalar arasında, ideal olarak 16. haftadan önce başlanmasını ve doğuma kadar sürdürülmesini önerir. ACE inhibitörleri gebelikte kontrendikedir; diüretik ve tuz kısıtlamasının koruyucu etkisi yoktur.

Soru 14 — Cevap: E) Preeklampsi risk faktörü olmayan gebede yalnızca fetal büyüme kısıtlılığını önleme amacı

Aspirin, preeklampsi riskini azaltmak amacıyla verilir. ACOG, preeklampsi risk faktörü bulunmayan gebede **yalnızca** FGR, spontan preterm doğum veya gebelik kaybını önlemek amacıyla aspirin kullanımını önermez. A-D şıklarındaki durumların her biri tek başına aspirin endikasyonu oluşturan yüksek risk faktörüdür.

Soru 15 — Cevap: D) Yalnızca doğumdan önce gelişir.

Eklampsi antepartum, intrapartum ve **postpartum** dönemde görülebilir. Postpartum eklampsi çoğunlukla ilk 48 saatte gelişir ancak daha geç de ortaya çıkabilir; bu nedenle doğum sonrasında da kan basıncı ve semptom takibi sürdürülür.

Soru 16 — Cevap: D) Enalapril

ACE inhibitörleri (enalapril vb.) ve **anjiyotensin reseptör blokerleri** gebelikte kontrendikedir; özellikle 2. ve 3. trimesterde fetal renal disgenezi, oligohidramnios, kafatası kemikleşme defektleri ve neonatal böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Soru 17 — Cevap: C) Doğumu planlamak

Preeklampside kesin tedavi doğumdur. **37. hafta ve üzerinde**, ciddi özellik olmasa bile maternal/fetal değerlendirme sonrasında doğum önerilir; bu haftadan sonra beklemenin anne açısından yararı yoktur.

Soru 18 — Cevap: C) Maternal stabilizasyon sonrası doğumu gerçekleştirmek

Kontrol edilemeyen ciddi hipertansiyon ve pulmoner ödem, gebelik haftasından bağımsız olarak **gebeliğin sonlandırılmasını** gerektiren maternal endikasyonlardır. Anne stabilize edilir (antihipertansif tedavi, MgSO₄, pulmoner ödem tedavisi); doğum geciktirilmeden gerçekleştirilir. Durum izin veriyorsa fetal akciğer matürasyonu için kortikosteroid verilebilir ancak doğum bu nedenle ertelenmez.

Soru 19 — Cevap: C) Kronik hipertansiyon

ACOG'a göre **yüksek risk faktörleri**: önceki preeklampsi, çoğul gebelik, kronik hipertansiyon, tip 1 veya tip 2 pregestasyonel diyabet, böbrek hastalığı, otoimmün hastalık (SLE, antifosfolipid sendromu). Nulliparite, ≥35 yaş, obezite, aile öyküsü ve 10 yıldan uzun gebelik aralığı **orta risk** faktörleridir.

Soru 20 — Cevap: C) Ciddi özellikli preeklampsi düşünülerek maternal stabilizasyon, MgSO₄ ve uygun antihipertansif tedavinin planlanması

Hastada ciddi aralıkta kan basıncı, serebral/görsel semptomlar, trombositopeni, transaminaz artışı ve böbrek fonksiyon bozukluğu vardır: **ciddi özellikli preeklampsi**. Proteinürinin az olması tanıyı dışlamaz. Yönetim zinciri: akut antihipertansif tedavi + nöbet profilaksisi için MgSO₄ + maternal/fetal değerlendirme → 34. hafta ve üzerinde stabilizasyon sonrası doğum.

Bölüm II — Zor Vakalar

1 D	2 C	3 C	4 B	5 C	6 C	7 B	8 C	9 B	10 C
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Soru 1 — Cevap: D) Ciddi özellikli preeklampsi

Proteinüri eşik değer (300 mg/gün) altında olsa da preeklampsi tanısı için proteinüri şart değildir. Kan basıncı ciddi aralıkta olmasa bile **trombosit <100.000/μL** ile **baş ağrısı ve görme bozukluğu** ciddi özellik kriterleridir. Bu nedenle en doğru ve en eksiksiz tanı **ciddi özellikli preeklampsidir**. “Proteinürisiz preeklampsi” ifadesi tablonun ciddiyetini yansıtmadığı için eksik kalır. 20. haftadan önce hipertansiyon öyküsü olmadığından kronik HT ve süperempoze preeklampsi düşünülmez.

Soru 2 — Cevap: C) Antihipertansif tedaviyi acilen başlamak

15 dakika arayla ≥160/110 mmHg'nin devam etmesi **akut ciddi hipertansiyondur** ve hasta asemptomatik olsa da tedavi 30–60 dakika içinde başlanmalıdır (IV labetalol, IV hidralazin veya oral hızlı salımlı nifedipin). Bu hasta ciddi özellikli preeklampsi kabul edilir; 34. hafta üzerinde olduğu için MgSO₄ ve stabilizasyon sonrası doğum da planlanacaktır, ancak **ilk adım** kan basıncının düşürülmesidir. Geç preterm dönemde (34+0–36+6 hafta) daha önce kortikosteroid almamış seçilmiş hastalarda betametazon düşünülebilir; ancak kortikosteroid uygulamak veya tetkik sonucu beklemek için akut hipertansiyon tedavisi ve maternal endikasyonla yapılacak doğum geciktirilmemelidir.

Soru 3 — Cevap: C) Kalsiyum glukonat

Magnezyum böbreklerden atıldığı için **oligüri** birikime ve toksisiteye zemin hazırlar. Refleks kayı ve solunum depresyonu **magnezyum toksisitesinin** bulgularıdır. İnfüzyon durdurulur, solunum desteklenir ve antidot olarak **kalsiyum glukonat** (%10'luk, 10 mL IV yavaş) verilir; serum Mg düzeyi ölçülür. Furosemid Mg atılımını artırabilir ancak antidot değildir ve ilk seçenek olmaz.

Soru 4 — Cevap: B) HELLP sendromu

Anemi ve LDH ≥ 600 U/L (hemoliz), AST ≥ 70 U/L ve trombosit $\leq 100.000/\mu\text{L}$ ile Tennessee kriterlerinin tamamı karşılanmaktadır: **HELLP sendromu**. HELLP hastaların bir kısmında belirgin hipertansiyon olmadan da görülebilir. Akut yağlı karaciğerde (AFLP) ise **hipoglisemi**, belirgin koagülopati (uzamış PT, düşük fibrinojen), hiperamonyemi ve daha belirgin karaciğer yetmezliği beklenir; bu hastada glukozun normal olması AFLP'den uzaklaştırır. Kolestazda kaşıntı ve safra asidi yüksekliği ön plandadır, hemoliz ve trombositopeni beklenmez.

Soru 5 — Cevap: C) Antihipertansif tedavi düşünülmeli ve hedef kan basıncı $<140/90$ mmHg olacak şekilde yönetilmelidir.

Bu soru eski bilgi ile güncel bilgiyi ayırır. **CHAP çalışmasında** (2022) hafif kronik hipertansiyonu olan gebelerde $140/90$ mmHg eşiğinde tedavi stratejisi, yalnızca ağır hipertansiyon geliştiğinde tedavi edilmesine kıyasla daha iyi gebelik sonuçlarıyla (ciddi özellikli preeklamps, 35. haftadan önce endike preterm doğum, dekolman ve fetal/neonatal ölüm bileşiminde azalma) ilişkiydi ve **SGA riskini artırmadı**. ACOG bu sonuçları pratiğe entegre ederek kronik hipertansiyonda tedavi eşiğini **$140/90$ mmHg** olarak önermektedir. Kronik hipertansiyon yüksek risk faktörü olduğundan bu hastaya 12. haftadan itibaren düşük doz aspirin de başlanmalıdır, ancak aspirin antihipertansif tedavinin yerini tutmaz. MgSO_4 'ün bu tabloda endikasyonu yoktur.

Soru 6 — Cevap: C) Süperempoze preeklamps

Kronik hipertansiyon zemininde proteinürinin belirgin artması ve yeni gelişen trombositopeni ile transaminaz yüksekliği **süperempoze preeklamps** (ciddi özellikli) tanısını koydurur. HELLP tanısı için hemoliz kanıtı (LDH ≥ 600 U/L, şistosit, indirekt bilirubin artışı) gerekir; bu vakada hemoliz bulgusu verilmemiştir.

Soru 7 — Cevap: B) 12-28. haftalar arasında başlanabilir; ideal olarak 16. haftadan önce başlanması tercih edilir.

ACOG/SMFM: yüksek riskli gebelerde günlük 81 mg aspirin **12-28. haftalar arasında**, ideal olarak **16. haftadan önce** başlanır ve **doğuma kadar** sürdürülür. NICE de yüksek riskli kadınlarda 12. haftadan doğuma kadar günlük **75-150 mg** aspirin önermektedir. Aspirin koruyucu (profilaktik) bir tedavidir; hastalık bulguları ortaya çıktıktan sonra başlanmasının yararı yoktur.

Soru 8 — Cevap: C) 37. haftadan itibaren doğumun başlatılması önerilir.

NICE, preeklampside **37. haftadan itibaren 24-48 saat içinde doğumun başlatılmasını** önerir. 34-37. haftalar arasında ciddi özellik ve maternal/fetal endikasyon yoksa yakın izlem sürdürülür; ancak durum kötüleşirse daha erken doğum gerekebileceğinden “her koşulda beklenmelidir” ifadesi yanlıştır. Proteinüri miktarı doğum kararını belirlemez; preeklamps tek başına sezaryen endikasyonu değildir.

Soru 9 — Cevap: B) Mirror (ayna) sendromu

Mirror sendromu (Ballantyne sendromu): fetal hidrops ve plasentomegali varlığında annede fetüsün tablosunu “aynalan” ödem, hipertansiyon ve proteinüri gelişmesidir. Preeklampsiden farklı olarak **hemodilüsyona bağlı anemi** (hematokrit düşüklüğü) tipiktir. Hidropsun nedeni tedavi edilebilirse (ör. fetal anemi için intrauterin transfüzyon) tablo gerileyebilir; aksi halde çoğunlukla doğum gerekir. Akılda tutma: **fetal hidrops + plasentomegali + maternal ödem/hipertansif tablo = Mirror sendromu**.

Soru 10 — Cevap: C) Trombotik trombositopenik purpura (TTP)

Normotansif hastada **çok ağır trombositopeni** ($<30.000/\mu\text{L}$), mikroanjiyopatik hemolitik anemi (şistosit, LDH çok yüksek, belirgin anemi), **nörolojik bulgular** ve böbrek tutulumu birlikte **TTP**'yi düşündürür. HELLP'te karaciğer enzimleri genellikle çok daha yüksektir, hipertansiyon/proteinüri sıktır ve trombositopeni bu kadar derin olmayabilir. Tanı **ADAMTS13 aktivitesinin $<\%10$** olmasıyla doğrulanır; tedavi gecikmeden **plazmaferez** (plazma değişimi) başlanmasıdır. Belirgin böbrek yetmezliği ön plandaysa atipik HÜS de ayırıcı tanıda düşünülmelidir.